



# STRATÉGIE ARGUMENTAIRE

## Passage en catégorie B — Ambulanciers FPH

### I. Constat : un décrochage devenu intenable

*Quatre constats cumulatifs fondent désormais la légitimité de la revendication catégorielle :*

- Une grille salariale sous le SMIC pour les premiers échelons, alors que le métier suppose un diplôme d'État de niveau 4 (DEA) et des responsabilités cliniques engageant directement la sécurité du patient.
- Une profession laissée pour compte lors du Ségur de la santé 2020 : les aides-soignants et auxiliaires de puériculture — diplôme de même niveau 4 RNCP — sont passés de catégorie C à catégorie B au 1er octobre 2021 (décret n° 2021-1257). Les ambulanciers ont seulement été rattachés à la filière soignante par le décret n° 2022-1658, sans changement de catégorie : une reconnaissance d'appellation, pas de statut.
- Un référentiel DEA (arrêté du 11 avril 2022) qui ne couvre plus la réalité des missions exercées : transports sous contrainte psychiatrique, transports pénitentiaires, patients à risque infectieux élevé, transports mortuaires, Plans Blancs, transports de PSL, compétences SMUR.
- **Une pratique de classement par défaut sur des grades de catégorie C étrangers au métier d'ambulancier** : dans plusieurs CHU, des agents exerçant le métier d'ambulancier sont rémunérés sur des grilles ASHQ ou AEQ, sans lien avec le DEA détenu ni avec le corps créé par le décret n° 2022-1658.

C'est l'articulation de ces quatre constats — sous-rémunération, exclusion du Ségur, écart missions/formation, classement hétérogène — qui doit structurer l'argumentaire, et non chacun isolément.

### II. Huit axes argumentaires

#### Axe 1 — L'élargissement de fait des missions, au-delà du référentiel DEA 2022

Le référentiel DEA (5 blocs) ne couvre pas, ou de façon allusive : la gestion de la contrainte et de l'agressivité, la médecine de catastrophe et les Plans Blancs, les patients fragiles à risque infectieux élevé, les transports mortuaires nocturnes, les dix compétences SMUR (dossier AFASH 02/2026), le transport pédiatrique et néonatal spécialisé, et la maintenance de premier niveau outillée.

#### **Argument-clé**

*Un agent qui exerce des missions non couvertes par son référentiel engage sa responsabilité personnelle sans filet de compétence reconnu. C'est un argument de sécurité patient et de protection de l'agent — difficilement contournable par la Direction.*

## Axe 2 — Le précédent du Ségur : même niveau de diplôme, statut différencié

| Critère            | Aides-soignants (AS)                      | Ambulanciers FPH                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diplôme            | DEAS — Niveau 4 RNCP                      | DEA — Niveau 4 RNCP                                                                                |
| Durée de formation | 1 540 h                                   | 801 h + FAE SMUR optionnelle 175 h, hors RNCP                                                      |
| Filière FPH        | Soignante — catégorie B depuis 01/10/2021 | Soignante en droit (décret 2022-1658) — maintien de fait technique/logistique dans de nombreux CHU |
| Catégorie          | B — décret 2021-1257 du 29/09/2021        | C — aucune mesure catégorielle à ce jour                                                           |

### Argument-clé

*Il ne s'agit pas de revendiquer un privilège, mais de corriger une iniquité de traitement entre deux corps de diplôme et de niveau de risque comparables, l'un revalorisé en 2021, l'autre non. L'écart de durée de formation joue en faveur de l'argumentaire.*

## Axe 3 — Le déficit de formation : l'angle d'attaque le plus difficile à réfuter

Le dossier AFASH (version 02/2026) documente 12 compétences spécifiques exercées par l'ambulancier SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP, et recense 24 missions sur 32 hors périmètre DEA/décret n° 2022-629. La France est le seul grand pays à ne disposer d'aucun positionnement RNCP spécifique pour l'ambulancier spécialisé en urgence préhospitalière.

## Axe 4 — Transports de produits sanguins labiles sans formation reconnue — Exemple du CHU de Caen Normandie

Aucun bloc de compétences du DEA ne couvre les exigences de la chaîne du froid (arrêté du 10 septembre 2007), la traçabilité transfusionnelle ni la gestion des incidents de transport. Un ambulancier qui assure un transport de PSL engage sa responsabilité personnelle et celle de l'établissement sans cadre de compétence reconnu.

## Axe 5 — Plan « Zéro contention 2030 » : un risque déplacé vers le transport

L'annonce du 2 juin 2026 d'un objectif national « zéro contention » en psychiatrie déplace mécaniquement une partie du risque comportemental vers la phase de transport, sans solution de substitution pour les ambulanciers.

## Axe 6 — Privatisation et argument économique : le calcul de gestionnaire

| Poste de coût — statu quo                | Estimation documentée                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intérim paramédical (surcoût direct T2A) | 90 000–150 000 €/an (FHF/ANAP 2025)                        |
| Turnover 18 % annuel                     | 135 000–360 000 €/an (Hoppi 2026 ; FNTS 2022)              |
| Passage en catégorie B — 50 agents       | 150 000 à 200 000 €/an → INFÉRIEUR au seul surcoût intérim |

### Argument-clé

*Le coût du passage en B est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes et très largement inférieur au coût cumulé intérim + turnover + grèves.*

## Axe 7 — Sinistralité routière, abandon de protection institutionnelle et coût humain

Le témoignage d'une ambulancière du CHG Marchant (Toulouse), victime d'une agression routière en juillet 2017, abandonnée par sa direction faute de suite pénale, contrainte de financer elle-même sa défense juridique (gain de cause mi-2024), 10 mois d'arrêt de travail et séquelles psychologiques durables, illustre un mécanisme systémique d'abandon de protection sociale.

### Argument-clé

*Le témoignage du CHG Marchant démontre que le risque ambulancier inclut la sinistralité routière et l'exposition à un environnement hostile. La faible catégorie salariale empêche l'agent de se défendre juridiquement et l'expose à un abandon de protection par l'employeur.*

## Axe 8 — Disparités de classement statutaire au niveau national : une discrimination documentée sur pièces [NOUVEAU — 30/06/2026]

L'examen comparé de bulletins de paie d'ambulanciers internes en poste dans quatre CHU (Montpellier, Tours, Caen Normandie, Toulouse) révèle que le déficit de reconnaissance statutaire ne se limite pas au maintien généralisé en catégorie C : dans plusieurs établissements, des agents exerçant en réalité des missions de transport sanitaire hospitalier sont classés sur des grades de catégorie C étrangers au corps des ambulanciers, sans lien avec le DEA qu'ils détiennent.

- **CHU de Montpellier** — grade 8256, ASHQ (Agent des Services Hospitaliers Qualifié) classe normale, échelle 8091, indice 366, statut contractuel de remplacement, cotisant à l'IRCANTEC. Aucune mention du métier d'ambulancier sur le bulletin de paie.
- **CHU de Toulouse** — au sein du même établissement, un agent affecté à des missions de transport sanitaire est classé AEQ (Agent d'Entretien Qualifié), échelle C3, échelon 07, indice majoré 420, tandis qu'un autre ambulancier toulousain est reconnu au grade « Ambulancier » (échelle NC2, indice 377) : deux classements coexistent pour des missions comparables au sein du même CHU.
- **CHU de Tours et CHU de Caen Normandie** — le grade « Ambulancier » (code 4338) y est correctement attribué, mais avec des écarts d'indice (374 contre 367) et de statut (titulaire à Tours, contractuel à Caen), entraînant un régime de retraite différent (CNRACL contre IRCANTEC) pour un même intitulé de poste.

Sur la base d'un volume horaire identique (151,67 h mensuelles), l'écart de rémunération nette mensuelle entre l'agent le moins bien classé (Montpellier, ASHQ, 1 767,12€ net) et l'agent le mieux classé (Toulouse, grade AEQ à indice 420, 2 412,48€ net) atteint 645,36€, soit près de 7 750€ par an, pour des agents exerçant le même métier.

### Argument-clé

*Cette pratique de classement par défaut sur des grilles ASHQ ou AEQ — constatée dans deux établissements distincts, avec deux intitulés de grade différents, et y compris au sein d'un même CHU — démontre que l'absence de cadre statutaire unifié pour les ambulanciers de la FPH ouvre la voie à un classement discrétionnaire, au mépris du décret n° 2022-1658. C'est un argument de rupture d'égalité de traitement entre agents publics exerçant les mêmes missions, recevable devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et un levier supplémentaire pour exiger une instruction nationale contraignante de la DGOS.*

*Pièces à l'appui : bulletins de paie comparés (avril-mai 2026) des CHU de Montpellier, Tours, Caen Normandie et Toulouse, anonymisés.*

### III. Proposition opérationnelle — Module MHS

Bloc complémentaire au DEA · Format FAE SMUR (arrêté du 17 mai 2023). La création d'un Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS) reprend le format déjà validé de la FAE SMUR — immédiatement crédible auprès d'une Direction et d'une ARS, sans création ex nihilo.

| N° | Module                                     | Contenu                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 | Transport sous contrainte et agressivité   | Cadre légal contrainte, désescalade sans contention mécanique, gestion du risque comportemental en habitacle. |
| M2 | Transports sécurisés et pénitentiaires     | Conduite sous escorte, protocoles IRIS, transferts UHSI/UHSA, JLD.                                            |
| M3 | Patients fragiles, risque infectieux élevé | Radioprotection, fin de vie, aseptie renforcée, dispositifs invasifs, pédiatrie, bariatrie.                   |
| M4 | Transports mortuaires                      | Cadre réglementaire, posture relationnelle, protocoles de sécurité.                                           |
| M5 | Médecine de catastrophe et Plan Blanc      | Organisation chaîne médicale des secours, équivalence FAE SMUR.                                               |
| M6 | Maintenance de premier niveau              | Contrôles et dépannage simples avec outillage fourni.                                                         |
| M7 | Spécificités ambulancier SMUR              | Assistance gestes réanimation, damage control, NRBC, SSE, coordination interservices, HéliSMUR.               |

### IV. Plan d'action et séquençement de la négociation

| Échéance                                  | Action                                                                                                                                                                                | Objectif                                              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Court terme (protocole de fin de conflit) | Reconnaissance écrite de l'écart missions/référentiel · engagement à créer le module MHS · NBI/IFR transitoire · contrôle de conformité des grades (ASHQ/AEQ → Ambulancier) [nouveau] | Sécuriser des gains immédiats                         |
| 3–6 mois                                  | Documenter et chiffrer l'écart · intégrer le périmètre SMUR, PSL, et les disparités de classement constatées dans les 4 CHU [nouveau]                                                 | Dossier technique solide, non réfutable               |
| 6–12 mois                                 | Porter le dossier au niveau national via les fédérations · saisine DGOS sur la révision du décret n° 2022-1658 et sur l'harmonisation des grades                                      | Peser sur la DGOS pour une révision statutaire        |
| Au-delà                                   | Mobiliser le rapport de force inter-CHU lors des négociations salariales FPH                                                                                                          | Inscrire la revendication dans un calendrier national |

## V. Argumentaire chiffré — données CHU de Toulouse, activité 2025

Total des transports patients : 56 843 · Transports psychiatriques sous contrainte : 3 751 · Transports urgences : 4 033 · Turnover annuel : 18 % (9 départs sur 50 agents) · Coût intérim 20 % des postes : 90 000–150 000€/an.

Données nationales de référence : ~2 500 ambulanciers en FPH (sénatrice Laurence Cohen, juin 2023) · 4 490 projets de recrutement nationaux (BMO France Travail 2026) · turnover 18 % annuel (FNTS 2022) · accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière 2023).

## VI. Anticiper les objections de la Direction

| Objection probable                                                    | Réponse à apporter                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Le statut a déjà été revu en 2022 »                                 | Ce décret a changé le rattachement de filière mais pas la catégorie. Reconnaissance d'appellation sans reconnaissance statutaire.                                                                                                 |
| « C'est une charge budgétaire supplémentaire »                        | C'est un investissement en stabilité RH. Coût du passage en B < surcoût intérim + turnover + grèves.                                                                                                                              |
| « Les disparités de grade (ASHQ, AEQ) sont des cas isolés » [nouveau] | Ces classements sont constatés dans deux établissements distincts, avec deux intitulés différents, et y compris au sein d'un même CHU : il s'agit d'une pratique structurelle, documentée sur pièces, et non d'anomalies locales. |
| « L'agression du CHG Marchant est un fait divers »                    | Ce témoignage est un révélateur systémique de l'abandon de protection par l'employeur, corroboré par les statistiques nationales d'accidentologie et de violence.                                                                 |

## VII. Synthèse en une phrase

Le passage en catégorie B ne doit pas être présenté comme une revendication salariale isolée, mais comme la conséquence logique et déjà actée par les pouvoirs publics pour un corps comparable (les AS), rendue d'autant plus nécessaire que les missions réellement exercées par les ambulanciers — documentées via les modules M3, M7 et l'Axe 4 (PSL) — dépassent largement le périmètre couvert par leur diplôme d'État, que le dossier AFASH (02/2026) confirme et aggrave ce dépassement, et que l'Axe 8 démontre, sur pièces, que l'absence de cadre statutaire unifié conduit dans plusieurs CHU à un classement par défaut sur des grilles étrangères au métier d'ambulancier (ASHQ, AEQ) — et dont le coût du non-changement dépasse structurellement le coût du passage en catégorie B.

*Références réglementaires clés : Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 · Arrêté DEA du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 · Arrêté FAE SMUR du 17 mai 2023 · Décret AMU n° 2022-629 · Art. L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP · Plan « Zéro contention 2030 » (2 juin 2026) · GT VAE ambulanciers (7 novembre 2025) · Dossier AFASH version 02/2026 · Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles · Témoignage ambulancière CHG Marchant, juin 2026 · Bulletins de paie comparés, CHU de Montpellier, Tours, Caen Normandie et Toulouse, avril-mai 2026 [nouveau].*

Signataires :

Julien TERRE (CGT) ·

Sébastien GOUSSY (CGT) ·

Victor ALAVA (SUD) ·

Laurent BEZIA (représentant du personnel ambulancier) ·

Jérôme JEAN-CHARLES (représentant du personnel ambulancier)

CHU de Toulouse, Service Transport Patients, Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059  
Toulouse Cedex 9